

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ S-1・カペシタビンの服用日・休業日と残薬の管理
- ☐ 腎機能とS-1の用量、フッ化ピリミジン系の重複確認
- ☐ 電話フォローで悪心・下痢・発熱・食事を確認
- ☐ 胃切除後の食事・体重の変化を聴取し栄養指導へつなぐ
- ☐ 症状をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ

病院薬剤師

- ☐ HER2・CLDN18.2・PD-L1の結果とレジメンの整合性の監査
- ☐ シスプラチンの補液・Mg補充、制吐薬の設定
- ☐ ソルベツキシマブ初回の投与速度・制吐薬強化の管理
- ☐ T-DXd・ニボルマブのILD・irAE発症時の院内連携
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

病院と共有する情報

バイオマーカー・レジメン

検査値

悪心・下痢のGrade

食量・体重

2 主なレジメンと薬局での確認ポイント

レジメン	構成・投与スケジュール	周期	薬局での確認ポイント
SOX / CAPOX	オキサリプラチン(1日目)+S-1またはカペシタビン1~14日目内服	3週毎	内服日数と休業、寒冷刺激による急性しびれ、手足症候群(カペシタビン)
S-1+シスプラチン	S-1 1~21日目内服+シスプラチン(8日目)	5週毎	シスプラチンの大量補液・腎機能、高度催吐性の制吐薬
S-1単独(術後)	S-1 4週服用・2週休業を1年間	6週毎	腎機能に応じた用量、流涙・色素沈着、アドヒアランス
RAM+PTX	ラムシルマブ(1・15日目)+パクリタキセル(1・8・15日目)	4週毎	高血圧・尿蛋白、好中球減少、末梢神経障害
ソルベツキシマブ併用	ソルベツキシマブ+CAPOX/SOX 等	3週毎	初回の悪心・嘔吐(制吐薬の強化)、体重・食量
T-DXd	点滴(HER2陽性、化学療法後)	3週毎	咳・息切れ・発熱(ILD)、悪心・嘔吐、骨髄抑制

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑→重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意	S-1 ギメラシルの排泄低下	既往・疾患 腎機能低下	5-FU濃度↑→骨髄抑制・下痢	CCrに応じた用量が確認
注意	S-1・カペシタビン CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定の頻度を処方医と確認
注意	シスプラチン 毒性の重複	処方薬 アミノグリコシド系抗菌薬・ループ利尿薬	腎障害・聴覚障害↑	他院での抗菌薬・利尿薬の処方を確認
注意	ニボルマブ 免疫反応の増強	既往・疾患 自己免疫疾患・間質性肺疾患の既往	irAE・既往の増悪	既往歴と他院での治療状況を確認
確認	S-1 症状を隠す	市販薬 市販の胃腸薬・下痢止め	下痢・脱水の見逃し	市販薬の使用を聴取し、まず連絡するよう指導

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「S-1は2週飲んで1週休むなど、決まった日程で飲みます。休業日もカレンダーと一緒に確認しましょう」

確認:お薬手帳でHER2・CLDN18.2・PD-L1、腎機能(S-1の用量)、胃切除歴
△他のフッ化ピリミジン系・ワルファリンとの併用を確認

投与当日~5日

「吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲んでください。水分は少しずつこまめに」

確認:電話フォローで悪心・水分量・尿量(シスプラチン後)を確認

△水分がとれない・尿が少ない時は至急連絡

投与後1~2週

「37.5℃以上の熱や、1日4回以上の下痢が続く時は、すぐ病院へ連絡してください」

確認:電話フォローでnadir期の発熱、S-1の下痢・口内炎を確認

△発熱+悪寒、止まらない下痢は至急受診

次回来局時

「涙が出やすい、手足がしびれる、咳や息切れが続くなどの変化はありませんか」

確認:流涙・色素沈着、しびれのGrade、体重、咳・息切れ

△咳・息切れ・発熱はILDを疑い早めに受診